

Incontinence fécale (Fecal Incontinence)

WARWIKI

Information pour le patient · Pertes involontaires de gaz ou de selles — fréquentes et traitables

L'incontinence fécale (fuites de selles involontaires) consiste à perdre le contrôle des gaz ou des selles — avant d'atteindre les toilettes, ou sans s'en apercevoir. C'est bien plus fréquent qu'on ne le croit, surtout après un accouchement ou avec l'âge, et cela se traite. Il n'y a aucune raison d'en avoir honte : en parler à votre équipe soignante est la première étape vers une amélioration.

À propos de cette affection

Le contrôle des selles dépend des **muscles du sphincter anal**, du plancher pelvien, de la consistance des selles et des nerfs qui les coordonnent. Un problème sur l'un de ces éléments peut provoquer des fuites — de simples taches ou gaz jusqu'à la perte de selles formées.

Causes

- **Lésion du sphincter** — souvent après un accouchement (déchirure sévère) ou une chirurgie anale antérieure
- **Selles molles ou diarrhée** — plus difficiles à retenir que les selles formées
- **Constipation sévère** avec fuites autour de selles dures (fécalome)
- **Troubles nerveux**, prolapsus rectal ou syndrome de l'intestin irritable

Plusieurs facteurs sont souvent impliqués, et plusieurs peuvent être améliorés.

COMPRENDRE LES TERMES

Incontinence fécale

Perte involontaire de gaz ou de selles.

Sphincter anal

L'anneau musculaire qui retient les selles jusqu'au moment voulu.

OASIS

Déchirure obstétricale sévère (3e/4e degré) touchant le sphincter.

Fibres alimentaires

Agent de lestage qui raffermir les selles molles et réduit les fuites.

Biofeedback

Thérapie qui rééduque les muscles du plancher pelvien et du sphincter.

Neuromodulation sacrée

Traitement par stimulation nerveuse qui peut améliorer le contrôle.

Y A-T-IL VRAIMENT DES TRAITEMENTS EFFICACES ? Oui — la plupart des personnes s'améliorent nettement, souvent avec des mesures simples comme raffermir les selles et rééduquer les muscles. Des options plus avancées donnent également de bons résultats si nécessaire. Le plus difficile est d'en parler ; une fois fait, il existe un chemin clair vers un meilleur contrôle.

Comment on le diagnostique

- Un bilan sur la fréquence, la quantité et les facteurs déclenchants des fuites
- Un examen du sphincter anal et du plancher pelvien
- Parfois une échographie du sphincter, des tests anorectaux ou une endoscopie

Comment on le traite (étape par étape)

- 1 Contrôle des selles** — ajouter des fibres pour raffermir les selles, traiter la diarrhée ou la constipation, et établir une routine régulière.
- 2 Rééducation du plancher pelvien / biofeedback** pour renforcer et coordonner les muscles.
- 3 Médicaments** (antidiarrhéiques, par exemple) en cas de selles molles.
- 4 Options avancées** — neuromodulation sacrée, agent de comblement injectable ou réparation du sphincter.

Vivre avec

- Visez des **selles bien formées** grâce aux fibres et à une hydratation régulière.
- Allez aux toilettes à heures fixes ; protégez la peau et ayez du matériel adapté pour vous sentir en confiance.
- Notez les aliments qui aggravent les fuites (caféine, plats épicés, édulcorants artificiels).

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- **Du sang dans les selles**, ou des selles noires et goudronneuses
- Un changement nouveau ou marqué du transit, ou une perte de poids inexplicable
- De la fièvre ou des douleurs abdominales sévères

TROIS CHOSES À RETENIR

- 1.** L'incontinence fécale est fréquente et traitable — ce n'est pas une fatalité et vous n'avez pas à en souffrir en silence.
- 2.** Le traitement commence par raffermir les selles et rééduquer les muscles, puis passe à la stimulation nerveuse ou à la chirurgie si nécessaire.
- 3.** Parlez-en à votre équipe soignante — c'est l'étape clé. Signalez tout sang dans les selles, toute perte de poids ou tout changement important du transit.